

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	備血 Prepare Transfusion Blood				
編號	A31000-Q05-W-B32	制定者	N13 沈佳安	公布日期	91 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.9 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

護理人員能正確執行備血技術。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

（一）技術目的：

輸血前給予正確的作業程序，以確保病人安全。

（二）用物準備：

1. 抽靜、動脈血：

- (1) 採血用具：5 c.c.空針、血庫專用試管、列印檢體貼紙、檢體總包貼紙。
- (2) 消毒溶液：75%酒精棉片或 2%Chlorhexidine。
- (3) 無菌棉籤、無菌紗布、止血帶（抽靜、動脈血）。

（三）步驟及要點說明：

步驟	說明
1. 醫師以電腦輸入申請單，選好所要項目並存檔後，血庫即會接收到備血申請單。	若為紅血球血品之備血，則需作交叉試驗及抗體篩檢。
2. 護理人員查閱病人的血型報告。	若無報告，告知醫師開立醫囑需一起抽血至檢驗科加驗 ABO、Rh type（CBC 紫頭管）。
3. 核對電腦 HIS 系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、頻率，於核對狀態核簽“正確”，需雙重核對輸入見證護理人員之身分證與密碼，並列印檢體標籤黏貼於血庫專用試管。	1.血庫專用試管為 EDTA 紫色頭 10 c.c.管，每次抽血 5c.c.（小兒或難抽血者抽 3 c.c.即可）並且混合均勻。 2.病人進行首次輸血且未曾有 ABO 及 Rh type 檢驗時，核對檢驗醫囑後，系統會跳出

主題名稱	備血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B32	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明
	病人自訴血型欄位，護理師詢問病人後，須填寫病人自訴血型。
4. 洗手。	
5. 主護及見證護理人員（或醫生）一同攜帶備血用物至病人單位。	若同時有兩位以上病人皆須備血，則一次替一位病人抽血，將備血管攜回護理站放置妥當後，再執行另一位病人之備血程序，以免混淆而發生錯誤。務必不做預留檢體之動作，且檢體必須是出自於自己經手的。
6. 共同核對病人，向病人及家屬解釋備血原因，並詢問血型。	由兩位護理人員，至病人單位採血時，共同確認病人身份。若由醫師採血時，需由另一名護理人員陪同核對病人。確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
7. 確認病人無誤後，選擇適當抽血部位，以 75% 酒精棉片或 2%Chlorhexidine，由內向外環狀消毒 2-3 吋後，抽取血液 5c.c。	1. 由內往外環狀消毒 2-3 吋。 2. 採血後採血部位以 2X2 紗布或酒精棉片加壓止血 5-10 分鐘(視病人情況而定)。
8. 將病人血液抽取 5 c.c.放入備血試管。	
9. 再一次共同核對血庫專用試管上之檢驗標籤、醫囑號及檢驗單，並列印檢體總包貼紙，確認無誤後，將試管送至血庫做交叉試驗及抗體篩檢。	若三天之內有輸過血，則可省略此步驟，超過並可由電腦上查詢是否尚有備血。
10. 洗手、在電腦 HIS 系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”，需雙重核對輸入見證護理人員之身分證與密碼。	
11. 記錄備血日期、時間、血品。	
12. 血庫可領血後會通知傳送人員（假日、大夜需由護理人員通知），血品領回後將領血通知單（須簽名）交給傳送人員送回血庫。	切勿以輸血申請單至血庫領血。

備註：本院不能備血庫，只能立即領之血品為 FP、FFP、platelet、Cryo。

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	備血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B32	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/6

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 熊乃歡(2022)・體液供給-輸血・於蘇麗智等編著，實用基本護理學（九版，324-329）・華杏出版。

七、附件

(略)

主題名稱	備血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B32	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
91.01.31	1.0	新制定。	91 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.10.26	2.1	病患改病人。	100 年 10 月 26 日護理部技術標準委員會通過。
101.08.07	2.2	步驟及要點說明修辭。	101 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
101.11.07	2.3	步驟及要點說明 8.刪除：執行三消。	101 年 11 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
101.12.28	2.4	說明（二）用物準備(2)刪除：2%Tincture Iodine	101 年 12 月 28 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.09.16	3.1	新增步驟 1 及 11 說明內容。	103 年 09 月 16 日護理部技術標準委員會通過。
104.09.29	3.2	1. 第三項第(二)目用物準備內容更新。 2. 第三項第(三)目部份內容刪修。 3. 更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.09.13	3.3	修正第三項第(三)目之 2 病人辨識說明。	105 年 09 月 13 日護理部技術標準委員會通過。
106.09.18	3.4	1. 新增第三項第(三)目之 6 部份說明內容。 2. 更新第六項參考資料。	106 年 09 月 18 日護理部技術標準委員會通過。
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	備血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B32	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/6

修正日期	版本	修正說明	備註
107.10.17	3.5	1. 第三項第二目之 1 (1) 輸血專用標籤更改為列印檢體貼紙。 2. 第三項第三目步驟及要點說明內容部份修訂。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過
108.11.05	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.09.21	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.23	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.19	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.03.07	3.7	第三項第三目步驟及要點說明順序異動及內容部份刪修。	111 年 12 月 19 日護理技術組會議通過； 112 年 02 月 08 日護理長會議通過；112 年 03 月 07 日督導會議通過公布。
112.09.18	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	3.8	1. 第三項第二目用物準備新增檢體總包貼紙。 2. 第三項第三目步驟 7.說明新增：採血部位加壓 5-10 分鐘（視病人情況而定）。 3. 第三項第三目步驟 9.新增：列印檢體總包貼紙。	113 年 09 月 23 日護理技術組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	3.9	1.第三項第二目刪除：2X2，新增：無菌紗布。 2.第三項第三目步驟 3 說明新增：2.病人進行首次輸血且未曾有 ABO 及 Rh type 檢驗時，核對檢驗醫囑後，系統會跳出病人自訴血型欄位，護理師詢問病人後，須填寫病人自訴血型。 3.第六項參考資料修訂	114 年 09 月 15 日護理技術組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。

主題名稱	備血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B32	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註